

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE COIMBRA
Diário Clínico
Consulta Externa
15-11-2025 09:30
Dr(a). Judy Paulo (HUC-ONCOLOGIA MÉDICA MAMA)

47 anos, feminino

Diagnóstico: Carcinoma invasor NST mama esquerda, G3, ER-, PR-, HER2 0, Ki-67 70 %

Estádio clínico: cT2N1M0 - IIIA

PD-L1 CPS 15, NGS sem alterações acionáveis, BRCA1/2 negativo

Antecedentes: Hipotireoidismo (levotiroxina 100 µg id), apendicectomia, mãe com carcinoma mamário (62 anos)

História da Doença Atual

- 12-06-2025: nódulo mamário esquerdo palpável, 2 cm, astenia G1.
- 15-06-2025: biópsia mamária esquerda - carcinoma invasor NST G3, perfil triple-negative, Ki-67 70 %.
- 20-06-2025: PET-CT - lesão mamária esquerda hipermetabólica, adenopatias axilares homolaterais, sem metástases à distância.
- 05-07-2025: RM mamária - tumor 2,3 cm, envolvimento de ganglios nível I-II, sem invasão da pele ou pectoral.
- 12-07-2025: US mamária - confirmação de nódulo sólido, vascularização aumentada, linfonodos suspeitos (3 mm).

Tratamento Neoadjuvante

- 01-07-2025 a 01-11-2025: Paclitaxel 80 mg/m² semanal + Carboplatina AUC 1,5 (C1-C4) → atraso de 1 semana (neutropénia G2) → retomado sem redução de dose.
- 02-11-2025 a 01-11-2025: AC (Doxorubicina 60 mg/m² + Ciclofosfamida 600 mg/m²) q3 semanas (C1-C4) concluído.
- Toxicidades: neutropenia G2 (episódio, resolvido com filgrastim), epistaxe leve (autolimitada), alopecia progressiva (CTC G2).

ECOG-ps 0

PA 122/78 mmHg, peso 62 kg, TSH 2,1 µUI/mL.

Hemograma: Hb 13,2 g/dL, neutrófilos 1,8 10⁹/L, plaquetas 250 10⁹/L.

Função hepática e renal dentro da normalidade.

Exame físico: cicatriz de incisão de biópsia cicatriza, mama esquerda sem edema, linfonodos axilares palpáveis (2 mm, indolores).

RM mamária pós-quimioterapia (10-10-2025): redução tumoral para 1,5 cm, resposta parcial (RECIST 1.1), diminuição de linfonodos (máx 5 mm).

PET-CT de reavaliação (20-10-2025): captação residual moderada na lesão mamária (SUV 3,2), ausência de captação nos linfonodos, sem metástases à distância.

Cirurgia conservadora (lumpectomia) + esvaziamento axilar nível I-II, prevista para 10-12-2025.

Discutido em reunião MDT.

Procedimento Cirúrgico (12-12-2025)

- Lumpectomia com margens livres (0,5 cm), 12 linfonodos removidos, 1 positivo (micrometástase, 0,2 mm). Estadiamento pós-cirúrgico: ypT1cN1miM0.
- Patologia: carcinoma invasor NST, G3, sem invasão de pele ou músculo, margens negativas, Ki-67 55 %.

Pós-Operatório Imediato

- Alta 15-12-2025, sem complicações.
- Hemograma pré-alta: neutrófilos 2,0 10⁹/L, sem anemia.
- Medicação: analgesia leve (paracetamol), continuação de levotiroxina, profilaxia antibiótica (cefazolina 1 g id 24 h).

Sem febre.

Reavaliação Pós-cirúrgica (20-12-2025)

- Exame físico: cicatriz íntegra, sem linfonodos palpáveis.
- Laboratório: função hepática normal, TSH 2,0 µUI/mL.
- PET-CT de controle (20-12-2025): ausência de captação residual na mama operada, linfonodos axilares negativos, sem novas lesões.

Decisão: iniciar terapia adjuvante com pembrolizumab + capecitabina (metronômica) conforme protocolo KEYNOTE-522.

Início de Terapia Adjuvante (05-01-2026)

- Pembrolizumab 200 mg iv q3 semanas (ciclo 1), Capecitabina 1000 mg/m² bid d1-14 q21 dias (ciclo 1).
- Pré-medicação: anti-náusea (ondansetrona 8 mg id), hidratação iv.
- Avaliação de toxicidade: náuseas G1, fadiga G1, diarreia G0.

Seguimento 20-01-2026

ECOG-PS 0, peso 61,8 kg.

Hemograma: neutrófilos $1,9 \times 10^9/L$, sem queda significativa.

Toxicidade: diarreia G1 (gerenciada com loperamida), fadiga G1.

RM mamária de controle (15-01-2026): cicatriz sem realce, ausência de lesão residual.

Planeamento: continuar pembrolizumab até 12 ciclos (aprox. 9 meses), monitorizar capecitabina a cada 2 ciclos, repetir PET-CT em 6 meses (abril 2026).

Observações

- Paciente aderente, apoio familiar adequado.
- Mantém atividade física leve, dieta equilibrada.
- Discussão sobre fertilidade realizada; paciente optou por preservação (não aplicável neste momento por idade).

Próxima consulta: 10-02-2026 - revisão de ciclo 2 pembrolizumab, avaliação de toxicidade capecitabina, exames laboratoriais.

Pedido enviado à CFT.

Processado por computador - SClínico

Pag. 1/1